

Fecha Última Actualización: 15-06-2025 8:49:04

Página 1 de 2

Información Paciente

Nombre : Jaime Alonso Castañeda Castro
Edad : 70a 6m 7d
Dirección : Pje. Magdalena Mira 3927

Rut : 6.559.151-0
Fecha Nacto: 08/12/1954
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 1518919
Sexo : Masculino
Teléfono : 993192363

N° Epicrisis
444263

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Cirugía Sector B - Mediana Compleji
Unidad de Egreso : Cirugía Sector B - Mediana Compleji

Fecha Ingreso : 09/06/2025 12:39
Fecha Egreso : 15/06/2025 08:06

Días Estadía : 6

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Dolor abdominal

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

AM: Tx renal Diciembre 2020 2° Berger, Hiperparatiroidismo primario en estudio, HTA

Qx: Tx renal, apendicectomía, FAV izq

Meds: Tacrolimus 2 mg día (Ultimo control 26/05/25), cinacalcet, enalapril 10 mg c/12 hrs, carvedilol 6.25 mg día prednisona 5 mg, micofenolato 360 mg c/12 hrs

Alergias: Niega

Hábitos: Tabaco: Suspendido. OH ocasional Drogas no

Cuadro de 1 día de dolor abdominal cólico en HD de inicio brusco 8/10 EVA asociado a 4 episodios de vómitos alimentarios posterior a ingesta de comidas copiosas. Niega ictericia, coluria, acolia, síntomas urinarios ni respiratorios. Ingres a SU en buenas condiciones, afebril, escleras anictéricas, con dolor en HD. Se solicita lab que destaca leve elevación de ppii (PCR 11.9, leucos 21170), sin alteración de transaminasas significativas, lipasa normal. Se solicita TC AP c/c que describe cálculo impactado en bacinete con engrosamiento parietal de vesícula. Eco abdominal confirma calculo de 8 mm en cístico, signos de colecistitis aguda. Vía biliar extrahepática de calibre normal.

Lab 9/6: PCR 11.9 BT/BD 1.12/0.26 FA/GGT 172/63 GOT/GPT 32/24 Lipasa 18 Crea 1 (Previo 1.04) BUN 16 ELP 139/4.38/103 Hb 16 hcto 49.8% GB 21170 PlaQ 241000 TP 81% INR 1.14 TTPA 24.8

Imágenes:

09/06 TC AP c/c: Vesícula biliar sobredistendida con cálculo en bacinete asociado a leve engrosamiento parietal y cambios inflamatorios, signos de colecistitis aguda. Sin dilatación vía biliar.

09/06 eco abdominal: Hígado normal. Vesícula biliar sobredistendida de paredes engrosadas, en su interior a nivel del cístico se observa cálculo de 8 mm, Murphy ecográfico +. Leve ectasia vía biliar intrahepática. Vía biliar extrahepática de calibre normal. Páncreas y bazo sin alteraciones. Conclusión: Signos sugerentes de colecistitis aguda litiásica

Se realiza colecistectomía laparoscópica el 11/06/25 con colecistitis aguda gangrenosa, sin complicaciones.

Paciente en BCG, HDN estable, afebril, sin apremio ventilatorio, sin npauseas ni vómitos.
Tolera régimen liviano

EF

Fecha Epicrisis : 15/06/2025 08:49

Página 1 de 2

Fecha Última Actualización: 15-06-2025 8:49:04

Página 2 de 2

Anictérico. Hidratado

RR2TSSMP+SRA

Abdomen Distendido, blando, depresible, sensible leve difuso. RHA+ sin signos de irritación peritoneal.

Lab

-13/06/25 Ac Láctico 1.7 Bili T 0.33 Bili D 0.18 GGT 65 GOT 15 GPT 13 Crea 1.29 PCR 163 Glucosa 91 ELP 138 3.27 108 Hb 12.9 Leuco 18680 Plaq 219000

-14/06/25: BT 0.39, BD 0.11, FA 143, GGT 87, GOT 39, GPT 22, CREA 1.13, PCR 84, LEUCOS 7820.

-15/06/25 Bili Total 0.4 Bili D 0.17 GGT 129 GOT 40 GPT 30 Crea 0.93 BUN 16 PCR 60 Hb 14.5 Leuco 6710 Plaq 206000

En condiciones de alta y control ambulatorio

Diagnóstico de Egreso

Colecistitis aguda -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

En condiciones de alta y control ambulatorio

Plan Post Alta

Reposo relativo

Régimen liviano

Hidratación abundante

Paracetamol 500 mg 2 comp c 8 hrs x 5 días via oral

Metamizol 300 mg 1 comp c 8 hrs x 3 días via oral SOS

Omeprazol 20 mg 1 comp c 24 hrs x 10 días via oral

Amoxicilina + Ac Clavulanico 500/125 mg 1 comp c 8 hrs x 10 días via oral

Control en poli CDT pasillo 11 con Dr Luis Contreras el 26/06/25 a las 12 hrs. Acudir con epicrisis.

Reconsultar en servicio de urgencias en caso de dolor abdominal, fiebre, vómitos, coloración amarilla en piel o mucosas o en caso de creerlo necesario.

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Luis Contreras Soto

Becado/Residente

Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 15/06/2025 08:49

Página 2 de 2

Fecha de Impresión : Lunes, 04 de Mayo de 2026 13:28

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar